

Informe clínico resumido — canina “Chiqui”

Período analizado: 20/3/2026 – 13/9/2026 · **Fuente:** 40 planillas caseras diarias (glucemia, insulina, fármacos, comida) + 15 informes de laboratorio (1/2024 – 8/2026).

Referencia: github.com/mcphisto-netizen/registros-chiqui · Panel interactivo: [panel-chiqui.html](#) · Documento generado 13/9/2026.

1 · Diagnósticos y contexto

Diagnósticos	Diabetes mellitus insulino dependiente (posición 20/3/2026) · Hiperadrenocorticismo (Cushing) · Hipotiroidismo · Hepatopatía mixta (lipidosis difusa moderada + colangiohepatitis linfoplasmocítica, biopsia 26/5/2026) · Colectomía por mucocoele biliar (24-26/4/2026) · Gastroenteritis aguda 17-23/8/2026
Esquema actual (7-13/9)	Ayuno: T4 ¼ + Dipirona ¼. Mediodía y noche: Trilostano ½, Silimarina ¼, Fenofibrato ¼, Caninsulin 0,18-0,2 U (ajuste por lectura; omitida 12/9 mediodía por peso). Desde 12/9: Biletan enzimático ½ + Psyllium. Dieta antiinflamatoria desde 10/9: cerdo 125 g + manzana 20 g + boniato 25 g + sopa de moro (3 cucharadas).

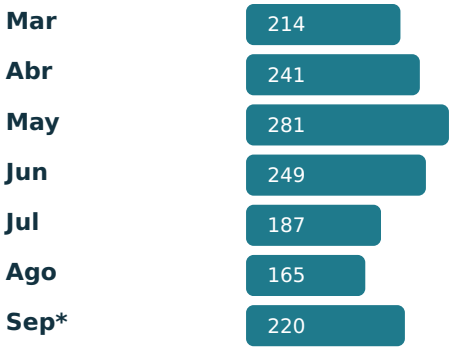
2 · Glucemia de las planillas

Valores domiciliarios; ante mediciones múltiples del mismo momento se registra la más baja (criterio acordado con el responsable, dos medidores: Maverick y Accucheck, con diferencia sistemática de ~16-20 mg/dL).

Mes	n	Media	Mín	Máx	n	Media	Mín	Máx
MEDIODÍA	(franja azul)			MEDIANOCHE	(franja violeta)			
Marzo (22-31)	11	214	164	267	12	236	129	441
Abril	27	241	140	514	28	262	150	495
Mayo	30	281	120	498	31	331	192	548
Junio	30	249	129	357	30	285	166	370
Julio	31	187	55	428	32	259	50	433
Agosto	31	165	40	260	31	225	62	341
Sept (1-13)	13	220	80	305	12	287	163	368

Media general del período: mediodía ~214 · medianoche ~264. Hipoglucemias <70 registradas: 7 (18/7, 19/7 ×2, 24/7, 13/8, 21/8, 24/8), mínima 40 (24/8) — corregidas con miel/pollo; curva documentada 8-10/8 (52 → 41 → rescate → rebote 341). Eventos: cirugía 24-26/4 y postoperatorio 27/4-10/5 (pico), gastroenteritis 17-23/8.

Mediodía · media mensual (mg/dL)



Medianoche · media mensual (mg/dL)



3 · Laboratorio relevante

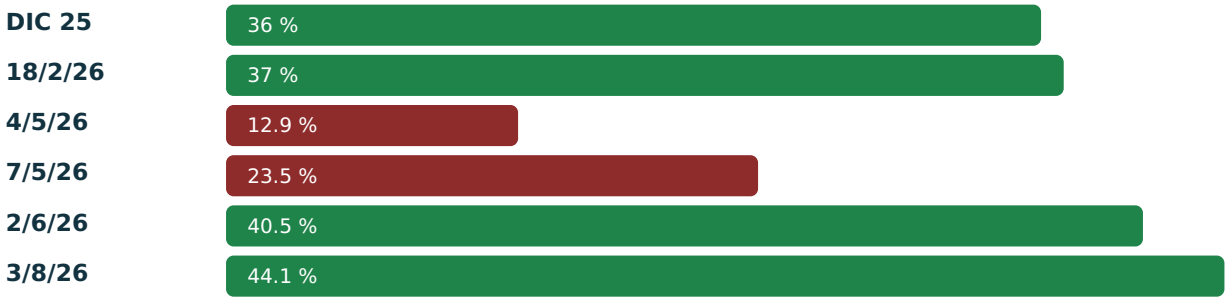
Fecha	Hallazgo	Lectura
18-20/2/26	Glucosa 487-508 · FAL 1626 · UCCR 4620/40,39 (alta) · T4 libre 0,17 + TSH 0,65 · plaquetas 934000	Debut triple: diabetes + Cushing + hipotiroidismo + colestasis marcada
4/5/26	Hto 12,9 · Hb 4,9 · ALT 160 · FAL 386 · glucosa 212 · amilasa 1163 · calcio 11,3 (corr 12,2)	Anemia severa postquirúrgica; laboratorio hepático ya en descenso
7/5/26	Hto 23,5 · leucocitos 14400 · reticulocitos 5%	Recuperación con respuesta regenerativa
26/5/26	Biopsia: lipidosis difusa moderada + colangiohepatitis linfoplasmocítica	Hepatopatía mixta
2/6/26	ALT 149 · FAL 136 · triglicéridos 819 · colesterol 309 · UPC 1,7 · cetonuria · suero lipémico	Mejoría hepática; proteinuria + hiperlipidemia franca
3/8/26	UCCR 22,8 (normal) · ALT 344 · FAL 283 · UPC 0,05 (normal) · T4 libre 0,70 (baja) · urea 95 · TG 277 · colesterol 281 · glucosuria 232	Cushing controlado; rebrote hepático; tiroides aún baja; riñón recuperado

LAB04 y LAB05 provienen de laboratorio humano: valores orientativos, rangos de referencia no aplicables. LAB02 = LAB03 (mismo protocolo del 3/8, completo en LAB03). Bilirrubina siempre normal; ácidos biliares 43 (LAB14). Densidad orina conservada (1010-1035).

Hígado — FAL (UI/l):



Hematocrito en evolución:



ALT (UI/l): feb 533 → 4/5 160 → 2/6 149 → 3/8 344. Urea 95 con creatinina normal (3/8) y urea 77,5 (4/5): control renal recomendable.

4 · Observaciones derivadas de los datos

- **El debut respondió rápido:** glucosa ~500 (feb) → ~214–236 en planillas (finales de marzo), -50% con insulina + Trilostano + T4.
- **Mayo = postoperatorio + anemia, no falla del esquema.** Hto 12,9 (4/5) y pico de hiperglucemias 400–548. Sin corticoides (por Cushing): estrés quirúrgico + inflamación + anemia. La serie roja se recuperó sola: 12,9 → 23,5 → 40,5 → 44,1 (ago).
- **Hígado independiente de la glucosa.** Mejoró tras cirugía (FAL 1626→136) pero **rebotó en agosto (ALT 344, FAL 283)**, cuando la glucemia promediaba su mejor valor (165). La biopsia nombra la causa (lipidosis + colangiohepatitis).
- **Cushing controlado:** UCCR de 4620/40,39 (feb) → 22,8 (ago, <40) bajo Trilostano ½ sostenido.
- **Tiroides posiblemente infratratada:** T4 libre 0,17 → 0,70, aún bajo rango (0,8–2,5) con ¼; aumento a ½ en agosto. Requiere control T4/TSH para confirmar dosis.
- **Riñón recuperado:** proteinuria jun (UPC 1,7) → ago (UPC 0,05). Creatinina siempre normal.
- **Lípidos rebeldes:** triglicéridos 819 → 277; colesterol clavado ~281–310 todo el año (fenofibrato justificado).
- **Brecha noche/mes continúa** (+20 a +70 sobre el mediodía): presenta picos nocturnos a pesar del descenso del promedio (dosis diseñada para franja diurna).
- **Glucosuria persiste (357 → 232)** coherente con la brecha nocturna.
- **Trombocitopenia dic-2025 (56.000) y amilasa 1652 sin diagnóstico** (atención veterinaria deficiente en ese período; sin evidencia de pancreatitis posterior a la fecha: ver roadmap).

5 · Roadmap sugerido

A · Estudios en el próximo control

#	Estudio	Justificación	Prioridad
1	Fructosamina	Sin ninguna en 2 años. Arbitra entre medidores/estrés de consulta, valida promedios y define ajuste de insulina. Interpretable hoy (albúmina 3,39). Bien para ello.	Alta
2	Lipasa pancreática específica canina (cPLI)	Amilasa 1652 (12/25) y 1163 (4/5/26) con antecedente de trombocitopenia: descarta/enfoca pancreatitis.	Alta
3	T4 libre + TSH	Validar si la dosis de ½ alcanza (T4l 0,70 con ¼).	Media
4	Bioquímica hepática + ácidos biliares	Control post-colecistectomía y post-Biletan/Psyllium (rebrote ago).	Media

5	UCCR de seguimiento	Consolidar control de Cushing.	Media
6	Rasme renal: urea/ creatinina/albúmina	Urea 95 con creat normal (3/8); urea 77,5 (4/5).	Baja

B · Ajustes terapéuticos y de manejo

- **Apuntar a la brecha nocturna:** considerar fraccionar/redistribuir insulina (o evaluar con fructosamina/curva si el pico vespertino es real) — la secuencia actual deja la noche cubierta por encima del objetivo.
- **Manejo de hipos:** 7 episodios <70 desde julio. Mantener protocolo de rescate (miel + pollo, como en 8–10/8) y revisar si el ½ de Trilostano en horarios del día coincide con caídas.
- **Seguimiento hepático:** repetir ALT/FAL ~1–2 meses tras inicio de Biletan/Psyllium (12/9/26) para evaluar respuesta al rebrote de agosto.
- **Dieta antiinflamatoria (10/9):** evaluar tolerancia y efecto sobre glucemia tras 4–6 semanas; documentar si mantiene el repunte de septiembre (> agosto).
- **Si cPLI positiva:** dieta baja en grasas y ajuste de fenofibrato/asesoría; si negativa, se descarta el foco pancreático y se refuerza el manejo metabólico.

Preguntas abiertas para el próximo control

- Fructosamina y cPLI: *nunca* realizadas.
- Etiología de la trombocitopenia de dic-2025 y de las plaquetas 934000 de feb-2026 (estrés/reactivo vs enfermedad primaria de médula).
- Posible sangrado gastrointestinal en dic-2025 o perioperatorio (no documentado).
- Correlación entre laboratorio (212, 4/5/26) y planillas caseras (400+) de la misma semana: suscita validación de medidores.

Documento generado automáticamente a partir de los registros digitalizados. Los valores domiciliarios son auto reportados por el responsable; los datos de laboratorio provienen de 15 informes originales (LAB01–LAB15) incluidos en el repositorio.

6 · Análisis cuantitativo avanzado

Observaciones elaboradas con **inteligencia artificial** a partir de los datos, contrastadas con bibliografía veterinaria citada al final. No sustituyen dictamen profesional. GLU=glucemia domiciliaria.

a) Tiempo en rango y variabilidad (objetivo canino 100–250 mg/dL — Merck/AAHA)

Mes	n	TIR 100–250	TAR >250	TBR <80	CV%	media	SD
03/26	23	83%	17%	0%	24.9%	226	56
04/26	59	61%	39%	0%	37.4%	252	94
05/26	64	33%	67%	0%	36.0%	299	107
06/26	60	30%	70%	0%	24.8%	267	66
07/26	64	52%	39%	6%	43.2%	226	98
08/26	63	63%	24%	8%	37.4%	193	72
09/26	26	46%	50%	0%	28.7%	250	72
TOTAL	359	50%	46%	3%	37.7%	246	93

CV% > 36% = distribución inestable y mayor riesgo de hipoglucemia (umbral humano ICAST/ADA, extrapolado). Solo 12/26 semanas alcanzan ≥50% de lecturas en rango. Mediodía CV 41% vs medianoche 32%: el día es la franja más inestable.

b) Brecha noche-día: real y significativa

Prueba pareada (Wilcoxon) en 171 días con ambos horarios: diferencia media de noche – mediodía = **+50 mg/dL, p = 7.6e-10**. En el **70%** de los días la noche supera al día ($p=3e-07$). El gap empeora: +23 (mar) → +52 (may) → +79 (jul) → +72 (sep). Correlación mediodía→medianoche $r=0,32$ ($p<10^{-4}$): una mañana alta arrastra la noche.

Coherente con la literatura canina (FGMS): glucemia nocturna más alta que diurna (JVIM 2021, 268 vs 259 mg/dL, $p<0,001$). Clave: revisar cobertura/fraccionamiento de la insulina nocturna, no solo el promedio.

c) Hipoglucemias y rebote (evaluación de Somogyi)

9 lecturas <80, todas 19/7–24/8. En 5/9 la siguiente lectura trepa a 255–295 (delta +76 a +224). **NO hay Somogyi clásico** (requiere mín <65 y máximo 400–800 y dosis $\geq 2,2$ UI/kg; aquí 0,18–0,2 UI). La curva 8/8–10/8 rebotó a 341 tras rescate con miel. El día posterior a una hipo la media *baja* (207 vs 250, $p=0,076$): descarta hiperglucemia rebote sostenida. El patrón encaja con **cobertura nocturna insuficiente**.

Panel: el responsable ya omite/reduce Caninsulin ante lecturas <150 en 21 oportunidades (25/7, 27/7, 19/7...): práctica alineada con guías AAHA (reducir si BG <150).

d) Fructosamina estimada — para validar el próximo dosaje real

Período	Glucosa media	Fructosamina estimada	Clasificación
Completo (mar–sep)	246	433 $\mu\text{mol/L}$	REGULAR (360–442)
Últimas 3 sem (24/8–13/9)	230	405 $\mu\text{mol/L}$	REGULAR (360–442)

Fórmula canina eAG = $0,59 \times F - 9,6$ (Kang 2015). Si el dosaje real sale <350, las planillas caseras subestiman la hiperglucemia (criterio del mínimo + medidores); si sale 400–440, se valida. Alerta (Kuzi 2023): F menor con hipos recientes puede parecer mejor control del real → leer junto con la planilla.

e) Dosis de insulina vs glucosa

Correlación dosis↔lectura del mismo momento ≈ 0 ($r=-0,01$ mediodía; $r=0,02$ noche). La respuesta diaria a la insulina domina la señal (variabilidad inter-día descrita en perros, JVIM 2021). El ajuste reactivo domiciliario es hoy el único mecanismo disponible sin CGM.

Conclusión del análisis

El mejor promedio de agosto esconde: (1) brecha nocturna que **empeora** (estadísticamente robusta), (2) CV global sobre el umbral de estabilidad con el mediodía más inestable, (3) solo ~50% del tiempo en rango, (4) hipos confinadas a jul–ago con overshoot moderado *sin* Somogyi franco, y (5) respuesta a dosis impredecible. Las dos preguntas que mejor resuelve el próximo control: **fructosamina** y **cPLI**, más redistribuir la cobertura nocturna.

Bibliografía consultada (IA, 13/9/2026 — enlaces en repositorio)

Ref	Fuente	DOI/PMID
1	AAHA Diabetes Management Guidelines (dogs/cats)	PMID 29314873
2	Merck/Vetsulin: glucose curves y Somogyi effect	merck-animal-health-usa.com
3	JVIM 2021: postprandial + glucemia nocturna (FGMS)	10.1111/jvim.16060
4	FreeStyle Libre metrics en perros diabéticos	PMC12175195
5	Kang 2015: eAG = $0,59 \times F - 9,6$ (perros)	PMC4397269
6	Cut-offs caninos fructosamina	PMC8880912
7	Kuzi 2023 (Vet Record): fructosamina e hipos	10.1002/vetr.2236
8	CV<36% umbral riesgo hipo (Castañeda 2023; Mo 2020)	10.1111/dom.15139 PMC8169344
9	Variabilidad día-a-día de insulina en perros	10.1111/jvim.16006

Glosario de abreviaturas

Abreviatura	Significado
TIR	Tiempo dentro del rango: % de lecturas en 100–250 mg/dL
TAR	Tiempo por encima del rango: % de lecturas > 250 mg/dL
TBR	Tiempo por debajo del rango: % de lecturas < 80 mg/dL
CV	Coefficiente de variación: desviación estándar / media × 100
SD	Desviación estándar
GLU / F	Glucosa (planillas) / Fructosamina (μmol/L)
eAG	Glucosa promedio estimada (estimated average glucose)
CGM / BG	Monitorización continua de glucosa / Glucosa sanguínea
UCCR	Cociente cortisol-creatinina urinaria (control del Cushing)
UPC	Cociente proteína-creatinina urinaria (proteinuria)
LPCE (cPLI)	Lipasa pancreática específica canina
Hto / Hb	Hematocrito / Hemoglobina
T4 libre / TSH	Tiroxina libre / Hormona estimulante de la tiroides